



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

**OCD hos børn og unge
– Tvangstanker og
tvangshandlinger**

Af Marie Tolstrup

OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger



Artiklen beskriver obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge, og hvad man i PPR med fordel kan være opmærksom på, i mødet med børn med denne lidelse. De obsessive tvangstanker og kompulsive tvangshandlinger defineres og uddybes, og illustreres gennem cases. Formålet med artiklen er at klæde PPR bedre på i forståelsen af OCD, hvorledes den adskiller sig fra andre angstlidelser, samt belyse, hvad man i mødet med barnet, forældre og skolepersonale med fordel kan vægte og tydeliggøre. I tilfælde hvor henvisning til psykiatrien er nødvendig, beskrives fokus for henvisningen, således at barnet og dets forældre bedst muligt bliver hjulpet videre.

*Af Marie Tolstrup, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi (børn),
privatpraktiserende psykolog*

Hvad er OCD?

Som ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), vil man før eller siden møde børn og unge som lider af en obsessiv kompulsiv tilstand (OCD). Det er derfor vigtigt at vide hvad OCD er, hvordan man identificerer det, udreder og behandler det, og hvordan det adskiller sig fra andre angstlidelser. Tvangslidelsernes skamfulde, bizarre og til tider væmmelige og voldsomme karakter, kan skræmme ikke blot barnet selv, men også forældre, lærere og såvel behandlere. Men gennem psyko-udikation, hvor viden om OCD deles, kan den ofte associerede stigmatisering punkteres, og symptomerne normaliseres. PPR kan gøre en stor forskel i at hjælpe barnet, dets forældre, og skolepersonale, med at forstå hvorfor barnet føler sig nødsaget til at tænke og gøre som det gør,

Obsessive compulsive disorder (OCD) er den engelske betegnelse for en obsessiv-kompulsiv tilstand. OCD er en angstlidelse som er kendetegnet ved tilstedeværelsen af tilbagevendende og ubehagelige tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner). Studier indikerer at mellem 2-3 % af befolkningen på et tidspunkt vil opfylde kriterierne for en OCD-diagnose (Thomsen & Weidle, 2015). OCD diskriminerer ikke ift. alder, men identificeres oftest i 9-10 års alderen. Før puberteten er OCD mest udbredt blandt drenge, men dette udlignes i ungdomsårene.

Den skam og væmmelse som ofte associeres med OCD, resulterer desværre ofte i, at børn ikke fortæller nogle om det. De skammer sig ofte over både deres vaner, såvel som indholdet af deres tanker, og deler dem derfor ikke med andre. De rapporterer at de er bange for

at blive til grin, eller at andre vil tro at de er sindssyge, og samtidig kan de selv være bange for tankerne og deres indhold, om hvorvidt de rent faktisk er sådan, eller kunne finde på at gøre noget sådan. Der er derfor ofte voldsom stigmatisering forbundet med OCD.

For at kunne diagnosticere OCD hos børn og unge, skal symptomerne stemme overens med visse kriterier. Ifølge *International Classification of Diseases 10th edition* (ICD-10), som er den seneste version af den diagnosemanual der benyttes i Danmark, skal barnet have haft tvangstanker og/eller tvangshandlinger i minimum 2 uger, og være bevidst om at det er deres *egne* tanker. Disse tanker og/eller handlinger skal være tilbagevendende, ubehagelige, erkendes som overdrevne eller urimelige, søges afvist eller modstået af barnet/ den unge, og oplevelsen af tvangstanker eller udførelsen af tvangshandlinger må ikke i sig selv være lystbetonet. Tvangstanker – og handlingerne medfører lidelse og forstyrrer barnets hverdagsfunktioner. Når disse kriterier opfyldes, taler man om enten en overvejende obsessiv tilstand, hvor det er tvangstanker som er de primære symptomer; en overvejende kompulsiv tilstand, hvor det er tvangshandlinger som er primære for symptombilledet, eller en 'blandet' diagnose, hvilket gives når det vurderes der er en ligelig fordeling mellem tilstedeværelsen af hhv. tvangstanker – og handlinger (World Health Organization, 1994).

Indtil 5. udgave af *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition* (DSM-V) udkom i 2013, som er den diagnosemanual der anvendes

i USA og i forskningssammenhænge, var OCD i ICD såvel som i DSM, forstået som en angstlidelse, og derfor kategoriseret derefter. I kategorien *Anxiety Disorders* i DSM-IV, var den placeret blandet andre angstlidelser såsom generaliseret angst, fobisk angst, og panikangst. Men ved udgivelsen af DSM-V, blev OCD fjernet fra angstlidelserne, og fik i stedet sin egen kategori; *Obsessive Compulsive and Related Disorders*, hvor lidelser som trikotillomani (hårplukning) og dermatillomani (hudplukning), nu også er placeret. Flere behandlere opfattede dette skift som yderst relevant, da OCD med dets ofte bizarre og grafiske indhold, og hertil relaterede stærke oplevelser af væmmelse og skam, altid har adskilt sig fra de andre angstlidelser. Selvom barnet med generaliseret angst, separationsangst, social fobi såvel som fobisk angst, godt kan have tjekkingadfærd (behov for at tjekke igen og igen, hvorvidt noget er som husket) og bekymringer relateret til hvorvidt de nu har husket at låse døren, at sige til mor og far at de skulle komme lige hjem efter arbejde, tjekke at de ikke har mad om munden, eller at der ikke er edderkopper under sengen, så adskiller denne *sikkerhedsadfærd* sig fra OCD i dets form såvel som i *graden* af forpinthed. Barnet med OCD vil opleve et markant ubehag såfremt det *ikke* får lov til at tjekke noget, på en måde og i en grad, så ubehaget neutraliseres. Og hvis barnet afbrydes i ritualerne, vil det have behov for at starte helt forfra, for at kunne opnå den nødvendige ro derved. Børn med andre angstlidelser vil ikke fremstå med samme rigide og stereotype adfærd, og

vil godt kunne blive afbrudt, uden nødvendigvis at føle sig nødsaget til at vende tilbage til adfærden og starte forfra. Barnet med OCD oplever også oftere skam i forhold til ikke at kunne styre sine tanker, – og dermed måske tror at *“jamen, så har jeg jo nok lyst til at tænke det”*, samt væmmelse i forhold til indholdet. Sammenlignet med andre angstlidelser, kræver OCD også ofte flere behandlingssessioner, og til tider behandlingssupplement i form af medicinsk behandling, for at opnå behandlingsmæssig succes. Med udgangspunkt i bl.a. ovenstående argumenter, mener flere dermed også at den fremtidige placering af obsessiv-kompulsiv tilstand i ICD-11, som forventes at udkomme i 2018, vil lægge sig op ad DSM-V, hvad OCD klassificering angår (Stein, Kogan, Atmaca et al., 2016).

Årsager til OCD menes at skyldes biokemiske såvel som psykologiske faktorer. Der ses en arvelighed ved OCD, hvor forældre til børn med OCD har en signifikant højere hyppighed af tvangssymptomer sammenlignet med andre forældre. Metaanalyser har ligeledes påvist at individer med OCD har en fire gange højere sandsynlighed for at have en slægtning med OCD, sammenlignet med individer uden OCD (Thomsen & Weidle, 2015). Det kan derfor være relevant at spørge ind til, hvorvidt forældrene kan genkende deres barns udfordringer fra dem selv, eller en nær slægning, især hvis deres OCD ikke er velbehandlet, og de måske derfor kan have den overbevisning, at OCD er noget som man bliver nødt til at lære at leve med, fremfor uden. Dette vil være relevant ift. behand-

lingsudbyttet. Der ses samtidig symptomforværring ved psykisk stress, og dårlig eller negativ kommunikation i familien kan være med til at vedligeholde symptomerne (Thomsen & Skovgaard, 2012).

Tvangstanker (obsessioner)

Når man skal identificere tvangstanker, skal man lede efter uønskede, tilbagevendende og generende billeder, ideer, og/eller indskydelser, som på stereotyp facon, dukker op i barnets bevidsthed igen og igen, og som barnet ofte forsøger at afvise, men for det meste uden held (WHO, 1994). Barnet med OCD kan godt tage afstand fra tvangstanker, og erkende at de er stærkt overdrevne og til tider noget urealistiske. Men det voldsomme ubehag som opstår i relation dertil, er for voldsomt, til at de 'bare' kan lade dem være. Dette resulterer i at de oplever en ufrivillighed, da de føler sig nødsaget til at handle eller reagere på tanker, for at få det ubehaget til at forsvinde.

Ifølge Thomsen (1998), placerer de almindeligste tvangshandlinger hos børn og unge således:

Tvangstanker:	
At blive snavset eller smittet	40 %
At der sker noget forfærdeligt	20 %
At blive syg	20 %
At dø	20 %
Symmetri	15 %
Sex	10 %
Religiøse tanker	10 %
Rædsel for at skade sig selv eller andre	8 %

Selvom nært beslægtede, adskiller tvangstanker sig fra *magisk tænkning*, som er en del af normaludviklingen hos yngre børn. Ved magisk tænkning, er barnet af den overbevisning, at ved at tænke noget, – gøre noget bestemt i en bestemt rækkefølge, eller et bestemt antal gange, at det dermed kan få ting til at ske. Et eksempel på magisk tænkning er at føle sig nødsaget til at undgå at træde på stregerne på fortovet, ellers når man ikke hjem inden det begynder at regne. Magisk tænkning ses ofte i relation til bamser, eller bestemt legetøj, som barnet til lægger en vis værdi eller særlig mening. Fx bliver de nødt til at sove med yndlingsbamsen, eller sige godnat på en særlig måde, for at undgå mareridt, eller for at der ikke skal ske noget med mor, far eller dem selv, mens de sover. Der hvor OCD'en bl.a. adskiller sig fra den magiske tænkning er i graden af ubehag, følelser af skam og væmmelse, såvel som i graden af gentagen stereotyp adfærd.

Tanker omhandlende smitte eller bakterier, er den mest almene tvangstanke. Her er barnet overopmærksom på hvad det rør ved, ofte såvel som i hvilken rækkefølge.

Mia på 15 år, havde længe været bange for bakterier. Hun følte sig ofte beskidt, og uanset hvor ofte hun vaskede hænder, og sprittede dem af, følte hun ikke, at hun kunne blive ordentlig ren. I skolen havde hun svært ved at koncentrere sig, da hun følte sig nødsaget til at holde øje med hvem der rørte ved hvad hvornår, i så fald hun var nødsaget til at røre ved noget de havde rørt ved. Hun havde travlt med at følge med i

den 'smitte-kæde' som foregik omkring hende. Nogle dage magtede hun ikke at tage i skole, da hun følte så voldsomt et ubehag, at hun ikke kunne overskue en hel dag fuld med bakterier.

Karakteristisk for individer der lider af OCD er perfektionisme, samt et voldsomt behov for kontrol, da dette – ligesom tvangshandlingerne, bliver en måde at forsøge at undgå eller neutralisere ubehaget på. Hos Mia blev hendes håndvask en tvangshandling, hvor med hun forsøgte at neutralisere det ubehag tvangstankerne forårsagede. Der ses tillige en tendens til at overvurdere den fare som knyttes til specifikke situationer, i en grad så disse situationer og hændelser forvrænges eller fejltolkes. Dette sås også med Mia, da hun forestiller sig at der er bakterier alle vegne, og at den eneste måde hun kan undgå dem på, er ved konstant håndvask og afsprøjtning. Det bør dog nævnes at des yngre barnet er, des mere svært kan det være for barnet, at forstå tankerne som værende overdrevne eller urealistiske. Dette hænger til dels sammen med det udviklingsmæssige overlap med magisk tænkning, men det kan også forstås som manglende livserfaring i forhold til hvad der reelt kan ske med en selv eller andre.

Nedenstående eksempel med Per, illustrerer umiddelbart samme problematik som Mia, – en følelse af at være beskidt og ulækker, *men* med et helt andet tankeindhold, og en højere grad af skam og væmmelse.

Per på 14 år, var voldsomt plaget af tvangstanker hvor han ville se billeder

inde i hovedet, hvor han seksuelt forgreb sig på sin lillebror. Per synes disse tanker var så pinlige og ulækre, at han konstant gik rundt og prøvede på at skubbe tankerne væk og for alt i verden ikke tænke på dem. Fordi Per følte sig så ulækker når han fik disse tanker, var han begyndt at gå i bad og vaske hænder oftere og længere tid af gangen. En dag lagde hans forældre mærke til at hans hænder var helt ru, og at der var små sprækker i huden mellem fingrene. Da forældrene i nogle uger havde forsøgt at afhjælpe Pers bad og håndvask, ved at fjerne sæbe og få ham ud af badet, opdagede de at Per stod op om natten for at fuldføre sine ritualer. Under udredningen hos psykologen, var det først da Per fik spørgsmålet: "Plages du af tanker eller billeder i dit hoved om sex, som får dig til at føle ubehag eller skam?", at Per brød sammen og delte sin forpintethed.

Per illustrerer vigtigheden i at identificere den eksakte tvangstanke, hvorved behandlingsfokus og relaterede eksponering, ændres afhængigt af tvangstankernes indhold.

Tvangshandlinger (kompulsjoner)

Tvangshandlinger eller ritualer forstås som en stereotyp adfærd, som gentages igen og igen (WHO, 1994). Adfærden er i sig selv ikke behagelig eller rar, tværtimod kan den ofte tilføre yderligere ubehag, eller øge følelsen af at være forpint, da barnet ikke selv oplever at have kontrol over denne adfærd. Adfærden udføres for at lindre eller neutralisere det voldsomme ubehag som barnet føler, og ud fra overbevisningen om, at såfremt den ikke udfø-

res, vil ubehaget voldsomt øges, eller en usandsynlig begivenhed indtræffe. Tvangshandlinger er altid akkompagneret af et forhøjet angstniveau, og dette angstniveau/ubehag dæmpes først når handlingen, som allerede nævnt, er udført tilstrækkeligt, længe nok, eller nok antal gange. Hvis barnet bliver forhindret i, eller ikke har mulighed for at udføre tvangshandlingerne korrekt, øges angstniveauet markant, og barnet har ikke tillid til at angstniveauet kan dæmpes på andre måder end ved ritualer. Ubehaget er voldsomt, og barnet vil derfor gå meget langt for at stoppe/undgå dette. Selvom tvangshandlinger oftere er nemmere at identificere – sammenlignet med tvangstanker, da man generelt kan se barnet udføre handlingen, kan handlingerne nogle gange være så diskrete og subtile, at det ikke lige ses med det blotte øje.

Rosa på 11 år, som havde mistet sin mor som spæd, oplevede et voldsomt ubehag når hun var væk fra sin far. Uden at hun egentligt vidste hvorfor, beroligede det hende at kradse 3-6-9 eller 12 gange på det samme sted på hvert lår samtidig. Til at starte med var det ikke noget nogle bed mærke i det, da hun kunne gøre det flere gange dagligt under bordet henne i skolen. Først ved start til svømning lagde hendes far mærke til to tydelige sår på begge låre. Rosa ville ikke gøre sin far ked af det, og på trods af at det først lykkedes hende at overbevise ham om at hun havde slået sig, hæftede faren sig ved det, og lagde mærke til at sårene ikke gik væk, men tværtimod blev værre, og tog derfor kontakt til skolepsykologen.

Ifølge Thomsen (1998) placeres de almindeligste tvangshandlinger hos børn og unge sig således:

Tvangshandlinger:	
Vask (hænder, brusebad)	50 %
Tjekking (døre, ledninger, apparater)	40 %
Gentage handlinger	40 %
Rette på og ordne ting	30 %
Bestemte ritualer	25 %
Tælleritualer	20 %

Ved tjekkingadfærd bliver barnet/den unge, rent faktisk i tvivl om hvorvidt de allerede har udført den pågældende tvangshandling. Denne tvivl nager dem, indtil de har fået lov til at tjekke igen, eller indtil fx en forælder har bekræftet at de rent faktisk har tjekket. På denne måde kan forældrenes adfærd komme til at vedligeholde og forstærke trangen til at spørge hvorvidt en handling rent faktisk er udført ordentlig, selvom de oftest blot svarer for at mindske, og dermed fjerne, deres barns voldsomme ubehag. Forældrene bliver dermed også nødt til at være tilgængelige, for ellers kan deres barn ikke regulere ubehaget, og dermed ikke trives. Dette mindsker forældrenes mobilitet, og dermed også resten af familiens (Thomsen & Skovgaard, 2012).

*Nina på 9 år, var plaget af tvangstan-
ker, omhandlende at hendes mor ville
komme ud for en ulykke på vej hjem fra
arbejde. For at mindske Ninas angst,
havde hun lavet en aftale med sin mor
om, at mor sendte 20 hjerter i en SMS*

*hver dag hun satte sig ind i bilen. På
den måde følte Nina sig sikker på, at
mor ville komme sikkert hjem. Men tal-
let 20 tog hurtigt om sig. Der gik ikke
længe før end at mor skulle sige hun el-
skede Nina 20 gange inden hun skulle
sove – ellers kunne mor dø om natten,
ringe til hende 20 gange i løbet af ar-
bejdsdagen, ellers kunne hun dø der,
mm.*

Tvangshandlingerne kan også komme til udtryk som tanker der skal tænkes igen og igen, som når barnet bliver nødt til at tælle til et bestemt antal et bestemt antal gange. Dette er ofte svært at identificere. Barnet kan her, blive misforstået og opfattet som fraværende eller uopmærksom, hvor barnet egentlig blot er optaget af at udføre ritualerne korrekt, således at ubehaget mindskes. Nogle børn formår at kunne udsætte deres tvangshandlinger, og på den måde vente med at udføre dem til senere. De kan fx vente med at udføre de fornødne ritualer indtil hjemme fra skole, men hvor det så har brug for flere timer til at fuldføre disse, før end at ubehaget er mindsket tilstrækkeligt. Barnet vil i den forbindelse begynde at trække sig fra legeaftaler, for dermed at få ro og tid til ritualer.

Hvad kan man gøre i PPR?

I vurderingen af mulig tilstedeværelse af tvangstanker – og handlinger, kan man med fordel skifte bekendtskab med Thomsen & Weidle's (2015) evidensbaserede behandlingsmanual for børn og unge med OCD, som er baseret på et forskningssamarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark, ved navn *The Nordic Long-Term OCD Treatment*

Study (NordLOTS). Bogen er en anbefalelsesværdig introduktion til OCD samt behandlingen deraf. Af spørgeskemaer som kan bruges til at identificere tilstedeværelsen af OCD, graden deraf, og samtidig adskille det fra andre angstlidelser, anbefales *Revised Child Anxiety and Depression Scale – RCADS* (Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto & Francis, 2000). RCADS består af 47 spørgsmål og måler angst og depression ifølge DSM-IV kriterierne, og udleveres til barnet såvel som til forældre. RCADS er hurtig og nem at administrere, såvel som at opføre. De mere specifikke tvangstanker – og handlinger, kan være svære at identificere hos børn, men der kan man med fordel benytte sig af *Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale – CY-BOCS* (Goodman, Price, Rasmussen et al., 1989), som findes i en lang såvel som en forkortet version. Ved brug af CY-BOCS kan man kortlægge symptomer samt grad af funktionsforstyrrelse. Begge spørgeskemaer kan dels hjælpe PPR med at vurdere hvorvidt barnets OCD er af subklinisk karakter, og dermed med fordel kan behandles gennem forholdsvist få samtaler med barn og forældre, eller hvorvidt det er af mere klinisk karakter, og dermed forstyrrer i en sådan grad, at psykiatrisk behandling er påkrævet.

PPR har gode muligheder for at gøre en forskel for de børn og deres familier, som er ramt af OCD. I ovenstående cases, sås en gradvis tilbagetrækkethed, og dermed begyndende social isolation. Ubehaget blev så voldsomt, at børnene trak sig fra de situationer, som ville udløse dette. I et forsøg på at undgå ubehaget, opstod der *undgåelsesad-*

færd, hvormed barnet undgår det som aktiverer eller højner angstniveauet/ubehaget. Som med alle andre angstlidelser, føles undgåelsesadfærd umiddelbart lindrende, men desværre kun i kort tid af gangen. OCD går ikke i sig selv, og undgåelsesadfærd forstærker blot overbevisningen om at noget er farligt, forbudt eller så ukontrollerbart, at man må undgå det for enhver pris. Undgåelsesadfærd kan være meget subtilt, da barnet ofte for at undgå ubehag, tænker og planlægger fremad, og fx påstår at have lektier for, for at undgå at gå ud at spise på restaurant med familien, hvor man ikke kan overvåge hvorvidt tilberedelsen af maden lever op til egne hygiejnekrav. Ved skolevægring, kan man i PPR være opmærksom på, hvorvidt skolevægringen kan forklares ved en OCD problematik.

Optagethed af tvangstanker – og handlinger, tager meget tid, og optager derfor meget tankevirkomhed, og dræner barnet for mentalt overskud. Dårlig koncentration og manglende evne til at opretholde opmærksomheden, tegner ofte et klinisk billede af børn med OCD, da de har for travlt med indre eller ydre ritualer, til at koncentrere sig om noget andet. Denne adfærd kan misforstås som manglende interesse eller forstås som værende symptomer på andre vanskeligheder, såsom manglende evne til at fastholde opmærksomheden, som kan være et tegn på en opmærksomhedsforstyrrelse. Her kan PPR være med til skabe opmærksomhed på vigtigheden af at skelne og differentiere, og stille spørgsmål der hjælper til at afklare, hvorvidt overopmærksomhed på indre tankevirkomhed, kan forklare den mang-

lende koncentration, og dermed støtte skolepersonale i at forstå forskellen derpå.

Den skam og væmmelse som ofte associeres med OCD, resulterer desværre ofte i, at børn ikke fortæller nogle om det. De skammer sig ofte over både deres vaner, såvel som indholdet af deres tanker, og deler dem derfor ikke med nogle. De rapporterer ofte at de er bange for at blive til grin, eller at andre vil tro at de er sindssyge, og samtidig kan de selv være bange for tankerne og deres indhold, om hvorvidt de rent faktisk er sådan, eller kunne finde på at gøre noget sådan. Der er derfor ofte voldsom stigmatisering forbundet med OCD. Ofte er det ikke blot barnet selv som føler skam eller væmmelse. Deres familie kan også skamme sig over hvad andre vil tænke om dem og deres barn, hvis de fandt ud af hvilke fx seksuelle eller aggressive tvangstanker deres barn går rundt med. Det er bl.a. derfor, at det er så vigtigt at inddrage forældrene både i forhold til forståelsen af hvad OCD er, såvel som i behandlingen deraf. Psykoedukation (undervisning om den pågældende lidelse) som understreger at man ikke er sine tanker, og at det blot er tanker, og at det ikke betyder at man vil handle på disse, er derfor ekstremt vigtig, og er noget som PPR med fordel kan hjælpe barnet og forældrene med at forstå. En tvangstanke er groft sagt ikke anderledes end andre tanker, men grundet dens indhold og det ubehag der opstår i relation hertil, bilder man blot sig selv ind at den er. En god pointe er ofte at minde barnet og forældrene om at deres tvangstanker faktisk er det *mod-*

satte af hvad de er, og hvad de står for og tror på. Det er bl.a. derfor de bliver så forpinte af at have dem.

Behandling og videre forløb

Når PPR personale oplever at barnets OCD forstyrrer i en grad, at det kræver psykiatrisk behandling, vil en god og tydelig beskrivelse af de pågældende tvangstanker – og handlinger, hjælpe barnet med at blive visiteret til de specialiserede OCD teams, som findes i flere dele af børne – og ungdomspsykiatrien. Her vil brugen af RCADS og CY-BOCS, hjælpe med at identificere tvangssymptomerne samt graden af funktionsforstyrrelse.

Den mest effektive behandlingsform og derfor anbefalede behandling i dag, er kognitiv adfærdsterapi (KAT). I Danmark har Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab udgivet kliniske retningslinjer for udredning og behandling af OCD, og KAT anbefales som førstevalg evt. suppleret med medicinsk behandling såfremt terapien alene, ikke er effektiv. Hovedkomponenten i KAT behandlingen af OCD, er eksponering og responsprævention (ERP), hvori barnet gradvist gør og/eller, udsættes for det frygtede, men undlader at udføre tvangshandlingerne. Formålet med dette er at gennem habituering, reduceres angstniveauet, og tankerne og/eller handlingerne, bliver unødvendige. For optimal behandling af OCD hos børn og unge, bør familien – som allerede nævnt, altid inddrages. Dette gøres både for at identificere og dermed mindske familiemæssige mønstre som ufrivilligt vedligeholder eller forstærker uhensigtsmæssige

mønstre eller adfærd, men også for at bryde den isolation som OCD'en fremmer, og dermed italesætte og fjerne den associerede skam. Forældrene har som barnet, oftest brug for konkrete redskaber til hvordan de håndterer barnets OCD. Det er vigtigt at terapien er målrettet barnets kognitive alder, såvel som graden af funktionsforstyrrelse. Da terapien ofte forstærker den ubehag som akkompagnerer OCD'en er psykoedukation, som tidligere nævnt, vigtig. Viden om OCD er med til at mindske stigmatisering samt fremme normalisering. Teknikker i forhold til at udholde ubehag når tvangshandlingen skal udsættes, og dermed opleve at det gradvist mindskes, selvom tvangshandlingerne ikke udføres, er vigtig. Imod slutningen af behandlingen kan det ligeledes være nødvendigt at ændre vaner, da tvangstanker – og handlingerne, kan blive så automatiske, at barnet ikke udfører dem bevidst.

Der findes individuelle såvel som gruppebehandlingsforløb for børn og unge med OCD. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at Cool Kids samt Chilled programmerne, som bruges ivrigt i psykiatrisk, kommunal såvel som privat regi, ikke er udviklet med OCD behandling for øje. Det er derimod Thomsen & Weidle's (2015) praksismanual. Som ved enhver anden angstlidelse skal forventningen til behandlingen være at barnet skal *behandles* for sin OCD. Det er således ikke noget man bør forvente at lære at leve med. Tværtimod skal man have hjælp til at lære at leve uden.

Referencer

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th ed.* American Psychiatric Publishing. London, England.
- Chorpita, B. F.; Yim, L.; Moffitt, C.; Umemoto, L. A., & Francis, S.E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: a revised child anxiety and depression scale. *Behaviour Research and Therapy*, 38, 835-855.
- Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., Heninger, G. R. & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use and reliability. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1006-104.
- Stein, D. J., Kogan, C. S., Atmaca, M., Fineberg, N. A., Fontenelle, L. F., Grant, J. E., Matsunaga, H., Reddy, U. C. J., Simpson, H. P., Thomsen, P. H., van den Heuvel, O. A., Veale, D., Woods, D. W., Reed, G. M. (2016). The classification of obsessive-compulsive and related disorders in the ICD-11. *Journal of Affective Disorders*, 190, 663-74.
- Thomsen, P. H. & Weidle, B. (red.) (2015). *Behandling af børn og unge med OCD – en praksismanual.* Hans Reitzels Forlag.
- Thomsen, P. H. & Skovgaard, A. M. (red.) (2012). *Børne – og ungdomspsykiatri – En lærebog om børn og unges psykiske sygdomme.* FADL's Forlag.
- Thomsen, P. H. (1998). OCD in children and adolescents. Clinical guidelines. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 7: 1-11.
- World Health Organisation (1994). *ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser – klassifikation og diagnostiske kriterier.* 1. udgave, 19. oplag 2015. Munksgaard.